

Objectif 40 de résidanat : hypothyroïdie de l'adulte et de l'enfant

Pr Debbabi W

Pr Ag Ajmi H

Dr Mghirbi O

Dr Ben Belgacem H

1. Concernant les hormones thyroïdiennes fœtales, quelles affirmations sont justes ?

- A. La thyroïde fœtale sécrète des hormones dès 12 semaines de gestation
- B. La T4 maternelle traverse le placenta et soutient le neurodéveloppement fœtal
- C. L'axe thyroïdienne fœtal est pleinement mature à la naissance
- D. La production fœtale de T4 devient détectable vers 18 semaines de gestation
- E. L'axe thyroïdien est plus immature chez le prématuré

2. Concernant l'hypothyroïdie congénitale, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le diagnostic est souvent retardé en raison d'un début insidieux des symptômes
- B. La confirmation diagnostique repose principalement sur l'examen clinique
- C. Le traitement substitutif est à vie
- D. Le dépistage néonatal systématique a amélioré le pronostic des enfants atteints
- E. La surveillance après initiation du traitement est facultative

3. Au cours des dysgénésies thyroïdiennes :

- A. L'athyréose correspond à l'absence totale de tissu thyroïdien
- B. Les ectopies thyroïdiennes représentent environ 50% des dysgénésies
- C. L'hémiagénésie thyroïdienne est la forme la plus fréquente de dysgénésie
- D. Les formes familiales de dysgénésie sont rares
- E. L'ectopie thyroïdienne est souvent localisée au niveau sous-lingual

4. L'hypothyroïdie congénitale par troubles de l'hormonosynthèse :

- A. Ils sont généralement sporadiques
- B. Ces troubles peuvent affecter la captation des iodures et leur organification
- C. Ils se transmettent selon un mode autosomique récessif
- D. La glande thyroïde est souvent absente
- E. Entraîne un goitre à la naissance

5. L'hypothyroïdie congénitale centrale est due à :

- A. Anomalies du développement hypothalamo-hypophysaire
- B. Mutations inactivatrices du récepteur de la TSH
- C. Syndrome d'interruption de la tige pituitaire
- D. Hyperstimulation hypothalamique excessive
- E. Mutations des facteurs de transcription de l'post-hypophyse

6. Hypothyroïdie périphérique par résistance aux hormones thyroïdiennes est :

- A. une hypothyroïdie congénitale primaire
- B. Liée à des mutations du récepteur β de la T3
- C. Due à des mutations du récepteur de la TSH
- D. Due à des anomalies du transport tissulaire des hormones thyroïdiennes
- E. est la plus fréquente d'hypothyroïdie congénitale

7. Hypothyroïdie congénitale transitoire peut être secondaire à :

- A. Carence en iode maternelle
- B. Traitement maternel par antithyroïdiens de synthèse
- C. Passage d'anticorps maternels anti-récepteurs de la TSH bloquants
- D. Exposition fœtale à l'iode radioactif
- E. Mutation du gène codant la thyroglobuline

8. L'hypothyroïdie périphérique peut s'accompagner :

- A. D'épanchement pleural
- B. Myopathie des muscles respiratoires
- C. Infiltration élastique et ferme de la peau et des muqueuses
- D. Diminution de la compliance pulmonaire par fibrose pulmonaire
- E. Des Troubles ventilatoires obstructifs

9. En cas d'hypothyroïdie on observe :

- A. Diminution du turnover des LDL
- B. Diminution de la température centrale
- C. Augmentation du péristaltisme intestinal avec diarrhées chroniques
- D. Hypotonie vésiculaire
- E. Hypoproduction d'érythropoïétine

10. Concernant les effets de l'hypothyroïdie sur la fonction gonadique et la puberté, quelles propositions sont exactes ?

- A. L'hyperprolactinémie est secondaire à une stimulation excessive de la TRH
- B. Une hypothyroïdie ancienne peut conduire à une puberté précoce centrale
- C. Troubles du cycle menstruel chez la femme adulte
- D. L'expression accrue de GnIH peut contribuer au retard pubertaire
- E. La puberté précoce s'accompagne d'une accélération de la maturation osseuse

11. Concernant les effets métaboliques de l'hypothyroïdie :

- A. Augmentation des HDL
- B. Hyperlipidémie athérogène
- C. Hypercholestérolémie
- D. Augmentation de la néoglucogenèse hépatique
- E. La synthèse des protéines est conservée

12. Concernant les répercussions hématologiques de l'hypothyroïdie, on trouve :

- A. Anémie multifactorielle
- B. Risque accru de thrombose
- C. Augmentation des facteurs de coagulation induite par la TRH
- D. Thrombopénie modérée
- E. Hypofibrinogénémie

13. Quels sont les symptômes d'alerte motivant un dosage de TSH chez le nouveau-né ?

- A. Fontanelle postérieure fermée
- B. Marbrures cutanées
- C. macroglossie
- D. Hypotonie
- E. Réflexes vifs

14. Le goitre néonatal :

- A. Est associé à une hyperthyroïdie fœtale.
- B. Peut entraîner une détresse respiratoire à la naissance.
- C. Peut être détecté à l'échographie anténatale.
- D. Peut provoquer des troubles de la déglutition.
- E. Peut entraîner une dyspnée

15. Les syndromes génétiques suivants sont associés à des hypothyroïdies frustes :

- A. Syndrome de Down
- B. Syndrome de Marfan
- C. Syndrome de Turner
- D. Syndrome de Prader-Willi
- E. Neurofibromatose de type 1

16. Le syndrome de Pendred associe :

- A. Goitre
- B. Surdit  de perception
- C. Anomalies osseuses de l'oreille interne
- D. Retard mental s v re
- E. Diab te insipide associ 

17. Les signes suivants peuvent se voir au cours d'hypothyro die cong nital chez le f etus:

- A. Diminution des mouvements actifs f taux
- B. Un oligoamnios
- C. Une bradycardie f tale
- D. Un d passement de terme
- E. Une macrosomie

18. Chez l'enfant, l'hypothyro die cong nitale peut entra ner :

- A. Un d ficit visuel
- B. Un d ficit auditif
- C. Des troubles de la m moire
- D. Une atteinte de la my linisation du syst me nerveux central
- E. Un nanisme harmonieux

19. L'hypothyro die cong nitale :

- A. Est souvent diagnostiqu e   la naissance sur des signes cliniques
- B. Est d pist e syst matique en Tunisie   j 5 de vie
- C. Est une cause  vitable de retard mental
- D. Est une endocrinopathie rare

E. Est dominée par les causes centrales

20. Une hypothyroïdie est suspectée chez le nourrisson devant :

- A. Des traits grossiers
- B. Macroglossie
- C. Un abdomen plat
- D. Hernie ombilicale
- E. Un stridor

21. Un nourrisson atteint d'une hypothyroïdie congénitale, peut présenter les signes suivants:

- A. Une bradycardie
- B. Une constipation
- C. Une hernie ombilicale
- D. Une macroglossie
- E. Un hirsutisme

22. L'hypothyroïdie congénitale transitoire peut être observé chez:

- A. Un nouveau né prématurité
- B. Un nouveau né de mère traité par le Basdène* (Benzylthio-uracyl)
- C. Un nouveau né ayant une athyréose
- D. Un nouveau né ayant une ectopie thyroïdienne
- E. Un nouveau né de mère diabétique

23. Les anomalies radiologiques suivantes peuvent être observées en cas d'hypothyroïdie congénitale :

- A. Une dysgénésie épiphysaire, de la tête fémorale.
- B. Une hypertrophie chondrocostale
- C. Une condensation de la base du crane
- D. Des vertèbres aplatis
- E. Une absence du point d'ossification fémoral inférieur

24. Les enfants atteints d'une athyréose:

- A. ont des taux effondrés de T4
- B. ont un pronostic meilleur que ceux présentant des troubles de l'hormonogénèse
- C. présentent un tableau clinique grave dès la naissance
- D. nécessitent un traitement précoce par des fortes doses de Lthyroxine
- E. ont une anomalie congénitale de la pompe à iode

25. Dans les ectopies thyroïdiennes :

- A. Il existe une sécrétion résiduelle d'hormones thyroïdienne
- B. Le tissu glandulaire est situé souvent en sublingual
- C. Les signes cliniques sont francs dès la naissance
- D. L'hypothyroïdie est transitoire
- E. La scintigraphie thyroïdienne est blanche

26. À propos du traitement par L-thyroxine chez l'enfant :

- A. Il est administré en dose fixe quel que soit l'âge
- B. Il doit être ajusté en fonction du taux de TSH
- C. La dose est plus élevée chez le nourrisson que chez l'adolescent
- D. Il est donné uniquement en cas de symptômes cliniques
- E. Il s'agit d'un traitement par voie injectable

27. Parmi les affirmations suivantes sur l'hypothyroïdie de l'enfant, lesquelles sont vraies ?

- A. Le traitement peut être arrêté systématiquement après 1 an
- B. Les formes transitoires peuvent justifier un arrêt après quelques semaines
- C. Le traitement par L-thyroxine est à vie dans la majorité des cas
- D. Une TSH normale permet d'arrêter le traitement
- E. Le traitement précoce évite le retard psychomoteur

28. Les objectifs du traitement substitutif par L-thyroxine dans l'hypothyroïdie de l'enfant sont :

- A. Assurer une croissance staturale normale
- B. Stimuler la sécrétion de TSH par rétrocontrôle
- C. Permettre une maturation cérébrale optimale
- D. Normaliser la glycémie

E. Supprimer les besoins en iode

29. Concernant les posologies de L-thyroxine en fonction de l'âge :

- A. Un nouveau-né reçoit environ 1,6 µg/kg/j
- B. Un enfant de 5 ans peut recevoir 3 à 5 µg/kg/j
- C. Un adolescent de 15 ans doit recevoir 10 à 15 µg/kg/j
- D. Un nourrisson de 12 mois reçoit en général 6 à 10 µg/kg/j
- E. La posologie est la même quel que soit l'âge

30. Parmi les éléments suivants, quels sont les effets attendus d'un traitement substitutif précoce et bien conduit chez l'enfant atteint d'hypothyroïdie ?

- A. Normalisation rapide de la croissance osseuse en quelques semaines
- B. Rattrapage statural dans 75 à 80 % des cas
- C. Disparition complète des troubles moteurs et du langage
- D. Récupération osseuse lente sur plusieurs années
- E. Réduction des séquelles neurologiques si traitement précoce

31. Quels sont les éléments à surveiller au cours du suivi d'un enfant traité pour hypothyroïdie ?

- A. Courbe de croissance
- B. Périmètre crânien
- C. L'âge osseux uniquement au début du traitement
- D. L'évolution de la fonction hépatique
- E. Le développement psychomoteur

32. Quelle est la fréquence optimale de dosage de la TSH en cas d'hypothyroïdie périphérique pendant l'ajustement du traitement ?

- A. Toutes les semaines
- B. Tous les 10 jours
- C. Tous les mois
- D. Tous les 6 mois
- E. Tous les jours

33. En cas d'hypothyroïdie centrale, quel est le paramètre biologique clé à surveiller ?

- A. T3
- B. TSH
- C. Calcitonine
- D. FT4
- E. Iode urinaire

34. Concernant le dépistage néonatal de l'hypothyroïdie congénitale :

- A. Il est réalisé entre le 3e et le 5e jour de vie
- B. Il nécessite une ponction veineuse systématique
- C. Il repose sur un dosage semi-quantitatif de la TSH
- D. Il est souvent inutile dans les pays à faible incidence
- E. Il permet un traitement précoce et améliore le pronostic

35. Parmi les situations suivantes, lesquelles peuvent rendre un test de dépistage faussement négatif ?

- A. Prématurité
- B. Nouveau-né macrosome
- C. Nouveau-né à terme
- D. Nouveau-né de faible poids de naissance
- E. Nouveau-né présentant une détresse respiratoire

36. Quelle est la conduite recommandée chez un nourrisson en bonne santé, âgé de 30 jours, présentant une TSH comprise entre 6 et 20 μ UI/ml avec une FT4 dans les normes ?

- A. Instaurer un traitement substitutif d'emblée
- B. Réaliser immédiatement une scintigraphie thyroïdienne
- C. Refaire un dosage de TSH et FT4 après 1 à 2 semaines pour confirmer l'anomalie biologique
- D. S'abstenir de tout suivi biologique si l'examen clinique est normal
- E. Considérer le test comme faussement positif

37. Parmi les éléments suivants, lesquels sont des facteurs influençant le pronostic neurologique dans l'hypothyroïdie congénitale ?

- A. L'instauration du traitement substitutif avant l'âge de 1 mois
- B. Le délai de normalisation de la TSH sous traitement
- C. L'étiologie de l'hypothyroïdie congénitale
- D. Le score d'Apgar
- E. La présence des signes cliniques d'hypothyroïdie

Cas clinique 1 :

Une mère atteinte d'une thyroïdite chronique d'Hashimoto vient d'accoucher. L'examen clinique de son nouveau né est normal.

1. Que risque ce nouveau-né ?

- A. Une hypocalcémie
- B. Une trisomie 21
- C. Un risque de malformation cardiaque
- D. Une hypothyroïdie congénitale
- E. Retard d'émission de méconium

2. Que feriez-vous afin de déceler ce risque ?

- A. Une Calcémie
- B. Échographie cardiaque
- C. Un test de Guthrie
- D. Réexaminer le bébé pour des signes hypothyroïdie
- E. Rien de particulier, étant donné que l'examen clinique est normal

3. Quel est le mécanisme physiopathologique lié à cette maladie ?

- A. Destruction auto-immune des cellules bêta du pancréas
- B. Hyperplasie des glandes parathyroïdes
- C. Atrophie des cellules alpha des îlots de Langerhans
- D. Destruction auto-immune des cellules thyroïdiennes
- E. Des anticorps anti-thyroïdiens maternels bloquant les récepteurs de la TSH,

4. Quelle est sa durée d'évolution de cette maladie?

- A. Généralement résolue à la naissance
- B. Évoluant vers l'aggravation rapidement en quelques jours
- C. Transitoire, se résolvant dans les premiers mois de la vie
- D. Permanente, nécessitant un traitement à vie
- E. Varie considérablement d'un cas à l'autre

Cas clinique 2 :

Un enfant âgé de 3 ans, ayant des antécédents d'hypothyroïdie familiale, est adressé pour exploration d'un retard de croissance et psychomoteur. À l'examen clinique, l'enfant présente un retard de croissance disharmonieux, des traits grossiers, une pâleur, un goitre, une macroglossie et une hernie ombilicale.

Vous suspectez une hypothyroïdie

1. Quelles sont les étiologies possibles à cette sa maladie ?

- A. Une athyréose
- B. L'ectopie thyroïdienne
- C. L'hypoplasie thyroïdienne
- D. Un trouble de l'hormonogénèse
- E. Insuffisance thyrotrope

2. Vous faites un âge osseux à cet enfant, en faveur de l'hypothyroïdie vous trouvez un :

- A. Âge osseux > âge statural
- B. Âge osseux < âge chronologique
- C. Âge osseux < âge mental
- D. Âge statural < âge chronologique
- E. Âge osseux = âge statural

3. Quelle mesure préventive aurait permis d'éviter le retard de diagnostic ?

- A. Vaccination précoce
- B. Supplémentation en vitamine D
- C. Suivi régulier chez le médecin scolaire
- D. Test de Guthrie à la naissance
- E. Échographie prénatale de la thyroïde

1. **Au cours de l'hypothyroïdie primitive, l'infiltration myxœdémateuse entraîne :**
 - A. Une hypoacousie
 - B. Une asthénie
 - C. Une péricardite
 - D. Des ronflements nocturnes
 - E. Une prise de poids

2. **Les signes suivants permettent d'évoquer une hypothyroïdie :**
 - A. Les palpitations
 - B. La présence d'un amaigrissement
 - C. La présence d'un myxœdème pré tibial
 - D. La présence d'une constipation
 - E. La frilosité

3. **Une hypothyroïdie transitoire peut être secondaire à :**
 - A. Une thyroïdite subaigüe de De Quervain
 - B. Un traitement par iode radioactif
 - C. Une thyroïdite du post - partum
 - D. Une thyroïdite d'Hashimoto
 - E. Une hypothyroïdie à l'amiodarone

4. **Les situations suivantes favorisent le coma myxœdémateux :**
 - A. Le froid
 - B. L'âge jeune
 - C. Le sexe masculin
 - D. Le traitement par Amiodarone
 - E. L'infarctus de myocarde

5. **Au cours du coma myxœdémateux on peut observer :**
 - A. Une hypernatrémie
 - B. Une hypoglycémie
 - C. Une élévation des enzymes musculaires
 - D. Une hypoxie
 - E. Une anémie

6. **Une hypothyroïdie primaire peut être secondaire à :**
 - A. Un myxœdème primitif de la femme ménopausée
 - B. Un traitement par amiodarone
 - C. Un syndrome de résistance aux hormones thyroïdienne
 - D. Une thyroiditesub-aigüe De Quervain
 - E. Une carence iodée

7. **La thyroïdite de Hashimoto est caractérisée par :**
 - A. La positivité des anticorps anti TPO
 - B. Une exophtalmie
 - C. Une survenue plus fréquente chez la femme ménopausée
 - D. Une atrophie thyroïdienne
 - E. Une thyroïde douloureuse à la palpation

8. **Au cours de la thyroïdite d'Hashimoto :**
 - A. Les anticorps anti-TPO sont les plus spécifiques
 - B. Peut être prévenue par un excès d'apport en iode
 - C. Peut être favorisée par les radiations ionisantes
 - D. Est associée à une thyroïde atrophique chez la femme jeune
 - E. Evolue vers la restitution ad integrum de la glande thyroïde

- 9. Les situations suivantes doivent inciter à la recherche d'une hypothyroïdie :**
- A. Une anémie microcytaire
 - B. une galactorrhée
 - C. Une hypertension artérielle
 - D. un amaigrissement
 - E. une hypercholestérolémie
- 10. Une hypothyroïdie peut se compliquer de :**
- A. Une myopathie
 - B. Une insuffisance cardiaque à débit conservé
 - C. Un syndrome d'apnée de sommeil
 - D. Une cardiopathie ischémique
 - E. Une encéphalopathie cortico-sensible
- 11. Devant une hypothyroïdie, on évoquera une origine centrale devant :**
- A. Un Antécédent d'accouchement hémorragique
 - B. La présence de goitre
 - C. La présence de myxœdème
 - D. Une hyperprolactinémie
 - E. Des anticorps anti-TPO positifs
- 12. Les éléments en faveur du caractère périphérique d'une hypothyroïdie sont :**
- A. L'infiltration cutanéo- muqueuse myxoedémateuse
 - B. la présence d'une aménorrhée
 - C. la présence d'un goitre
 - D. L'association habituelle à d'autres déficits endocriniens
 - E. La notion d'irradiation pour cancer de cavum
- 13. Une hypothyroïdie périphérique peut entraîner :**
- A. Une hypocholestérolémie
 - B. Une tendance à l'hyperglycémie
 - C. Une augmentation des enzymes musculaires
 - D. Une anémie macrocytaire
 - E. Une hypercalciurie
- 14. Au cours de la grossesse, une hypothyroïdie :**
- A. Présente un risque majoré d'avortement spontané en présence d'anti-TPO positifs
 - B. Expose à un risque accru d'hémorragie de la délivrance
 - C. Nécessite une augmentation des doses de Thyroxine dès le début de la grossesse
 - D. Nécessite une surveillance trimestrielle
 - E. Peut induire une atteinte du potentiel psycho-intellectuel de l'enfant en cas de déséquilibre
- 15. Un dépistage de l'hypothyroïdie au cours de la grossesse est recommandé chez une femme :**
- A. Agée de plus de 30 ans
 - B. Ayant un diabète de type 2
 - C. Ayant un antécédent d'avortement, de prématurité ou d'infertilité
 - D. Multipares (>2)
 - E. Vivant dans une région de carence iodée

16. Le traitement par L-thyroxine :

- A. Présente une meilleure biodisponibilité lorsqu'il est pris le matin à jeun
- B. Nécessite une adaptation des doses en cas de prise des inhibiteurs de la pompe à proton
- C. Augmente l'effet des AVK
- D. Diminue l'effet des antidépresseurs
- E. Contre indique l'allaitement maternel

17. Dans l'hypothyroïdie fruste traitement est recommandé si :

- A. La TSH > 10 mU/L
- B. Les Anti-TPO sont positifs
- C. Si les anti Thyroglobulines sont positifs
- D. Présence de signes cliniques d'hypothyroïdie
- E. Présence d'une hypercholestérolémie

Cas clinique 1 :

Mme B 73 ans est traitée par amiodarone (Cordarone) pour des extrasystoles gênantes, et par statine pour une hypercholestérolémie, son chiffre de cholestérol est stable à chaque contrôle. Depuis un mois, la patiente est fatiguée et ralentie. Elle est frileuse. Sa fille la trouve déprimée. Elle a des douleurs musculaires de plus en plus intenses. A l'examen clinique, la TA est à 120/80 mmHg, pouls régulier à 56/mn, la palpation cervicale est normale.

Biologie : hémoglobine à 10.2 g/100ml ; VGM 104. La VS et la CRP sont normales, la créatinine à 56 mmol/l ; glycémie : 0,92g/l, CPK : 2420 U/l (N inf à 180) ; TSH ; 83 mU/l (0.3-4.8) ; T4 libre : 3 pg/ml (7-20), Anticorps anti-thyroperoxydase positifs à 123 U/l (normal inf à 60).

En relisant le dossier, vous notez que la TSH six mois auparavant était à 8,4 mU/l.

L'ECG montre un rythme sinusal avec un microvoltage diffus.

L'échographie cervicale montre une thyroïde diminuée de volume.

Une hypothyroïdie est retenue.

18. Cette hypothyroïdie peut avoir comme étiologie :

- A. Une cause hypophysaire
- B. La prise d'amiodarone
- C. Un myxoedème primitif
- D. Une thyroïdite de De Quervain
- E. La prise de statines

19. Les paramètres biologiques en faveur de l'hypothyroïdie sont :

- A. L'anémie macrocytaire
- B. Le taux des enzymes musculaires
- C. La glycémie
- D. L'hypercholestérolémie
- E. Les données de l'ECG

20. Les mesures thérapeutiques chez cette patiente comportent :

- A. La L Thyroxine à doses progressives
- B. L'arrêt des statines
- C. L'arrêt de l'amiodarone si l'état cardiaque le permet
- D. La prescription de vitamine B12
- E. Un traitement martial

21. Le suivi du traitement nécessite:

- A. Le dosage couplé de la TSH et la FT4
- B. Une NFS
- C. Une échographie cervicale
- D. Le dosage des anti-TPO
- E. Un bilan lipidique

Cas clinique 2 :

Une femme de 34 ans, ayant une sœur diabétique de type 1, , dernière grossesse remonte à 3 ans , consulte pour aménorrhée secondaire de 4 mois. L'interrogatoire révèle une asthénie d'aggravation progressive, myalgies et crampes musculaires.

L'examen trouve : infiltration cutanée, macroglossie, chute de la queue des sourcils, dépilation axillo-pubienne et galactorrhée. Il existe un goitre hétérogène à la palpation de la thyroïde.

22. Ce tableau évoque une hypothyroïdie. Vous demandez en première intention :

- A. Une échographie cervicale
- B. Un dosage de la TSH
- C. Un dosage de la TSH et de la FT4
- D. Un dosage de la FSH et LH
- E. Un dosage de la Prolactinémie

23. Quelle étiologie de l'hypothyroïdie évoquez-vous ?

- A. Une thyroïdite de Dequervain.
- B. Une thyroïdite du post-partum
- C. Une thyroïdite d'Hashimoto
- D. Une carence iodée
- E. Une insuffisance thyroïdienne secondaire à une hypophysite auto-immune

24. Cette hypothyroïdie peut se compliquer de :

- A. Une rhabdomyolyse
- B. Un flutter auriculaire
- C. Un Bloc auriculo-ventriculaire
- D. Une anémie macrocytaire
- E. Une hypokaliémie

Cas clinique 3 :

Madame Aicha âgée de 32 ans a pris 6 kg en 8 mois, malgré une activité sportive régulière. Elle se plaint de fatigue récente et ne prend plus plaisir à s'occuper de ses deux enfants âgés respectivement de 5 et 3 ans.

Elle rapporte une chute des cheveux, des crampes musculaires et des myalgies. Elle a un vitiligo depuis 10 ans.

L'examen note un goitre diffus et homogène, une dépilation de la queue des sourcils et une infiltration cutanée. La TA est à 12/07 cm Hg. Fréquence cardiaque : 50 b/mn. Pouls périphériques présents.

Elle est traitée par des statines depuis 3 mois pour une hypercholestérolémie.

Le bilan montre :

Glycémie à 5 mmol/l, kaliémie à 4,2 mmol/l et une natrémie à 138 mmol/l. calcémie : 2,3 mmol/l, Cholesterol total : 5,4 mmol/l, Triglycérides : 1,6 mmol/l, HDLc : 0,7 mmol/l, LDLc : 1,53 g/l, Hb : 9g/l, plaquettes : 264000 / mm³, GB : 6000 / mm³
TSH : 68 mUI/l, FT4 : 2,1 pmol/l

25. En faveur de la thyroïdite d'Hashimoto chez cette patiente on trouve :

- A. La chute des cheveux et la dépilation
- B. L'antécédent de vitiligo
- C. La présence du goitre
- D. Les crampes musculaires
- E. Le myxœdème

26. Les crampes musculaires chez cette patiente peuvent être dues à :

- A. Une hypokaliémie
- B. Une atteinte musculaire secondaire à une hypothyroïdie
- C. Une toxicité des statines
- D. Une artériopathie oblitérante des membres inférieurs
- E. Une hypoparathyroïdie

27. Le traitement de cette patiente nécessite :

- A. La LThyroxine
- B. L'augmentation de la dose des statines
- C. La prescription d'un bêtabloquant
- D. Un traitement martial
- E. La prescription d'une fibrates

28. Un an après début de traitement la patiente revient désireuse d'une grossesse. Vous lui expliquez que :

- A. L'objectif de sa TSH en pré-conceptionnel doit être inférieur à 2,5 mUI/l
- B. Une augmentation de la dose est prévue dès le début de la grossesse
- C. Un dosage des anticorps anti-TPO sera demandé en début de grossesse
- D. Un dosage de la FT4 sera demandé en parallèle avec la TSH
- E. Une échographie fœtale mensuelle sera prévue

Cas clinique 4 :

Une jeune femme de 28 ans vient consulter pour une aménorrhée secondaire depuis 4 mois. Après la naissance de son premier enfant, il y a 8 mois, son retour de couches s'est effectué normalement pendant 3 cycles puis une aménorrhée s'est installée. Elle rapporte juste après son accouchement une perte rapide de poids et un retour en quelques semaines à son poids d'avant la grossesse. Elle se plaignait alors de fatigue, de sueurs et de palpitations à l'effort. Actuellement, elle se sent dépressive, toujours fatiguée et a tendance à reprendre du poids sans qu'elle ait modifié son alimentation.

Son exploration montre : urée : 5 mmol/l, glycémie : 5,1 mmol/l, hémoglobine : 9 g/100ml, VGM : 86, cholestérol : 8 mmol/l, anti-corps anti-thyroperoxydase positifs à 2500 UI/l. Son bilan hormonal montre : T4 libre : 5 pg/ml (VN : 7-12 pg/ml), TSH : 30 mUI/l (VN : 0,2 – 5 mUI/l).

Une hypothyroïdie secondaire à une thyroïdite du post-partum est retenue

29. Cette pathologie :

- A. Peut-être une variante de la thyroïdite subaiguë silencieuse
- B. Peut-être une variante de la thyroïdite subaiguë silencieuse
- C. Peut survenir après une fausse couche
- D. Le risque de récurrence lors des grossesses suivantes rejoint celui de la population générale
- E. L'évolution vers une hypothyroïdie permanente est quasi-constant

30. Le risque de survenue d'une thyroïdite de post-partum est particulièrement fréquent chez les femmes :

- A. Diabétiques de type 1,
- B. Porteuses d'anticorps anti-TPO en début de grossesse,
- C. Obèses
- D. Tabagiques
- E. Ayant des antécédents de thyroïdite subaiguë de De Quervain

31. Le traitement chez cette patiente repose sur :

- A. La corticothérapie
- B. La L Thyroxine
- C. Les statines
- D. Le Fer
- E. Un antidépresseur